CRIBADO DEL RIESGO HEMORRÁGICO · HEMSTOP · ANAMNESIS ESTRUCTURADA

Cribado del riesgo hemorrágico preoperatorio (HEMSTOP)

La mejor prueba de coagulación preoperatoria es una buena historia clínica — no el TP/TTPa de rutina

Por qué no cribar con TP/TTPa · El cuestionario HEMSTOP · Interpretación del score · A quién estudiar más · Límites

Ancla de evidencia (referencia vertebral): Bonhomme F, Boehlen F, Clergue F, de Moerloose P. *Preoperative hemostatic assessment: a new and simple bleeding questionnaire (HEMSTOP).* Can J Anaesth 2016;63(9):1007–1015. doi:10.1007/s12630-016-0688-9 · PMID 27369959.

2026 · 3 referencias indexadas verificadas en PubMed · Síntesis docente para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL)

Mensaje nuclear: el cribado de coagulación con TP/TTPa de rutina en pacientes asintomáticos es ineficiente y genera falsos positivos. La estrategia correcta es una anamnesis estructurada del riesgo hemorrágico (como el cuestionario HEMSTOP) y reservar las pruebas para quien tenga historia o clínica sugestiva.

Pedir TP y TTPa «por protocolo» a todo paciente antes de cirugía parece prudente, pero no lo es: detecta mal los trastornos hemorrágicos relevantes (muchos cursan con coagulación básica normal) y produce hallazgos anómalos sin significado que retrasan y encarecen [1].

Este documento abre el eje de hemostasia clínica con la herramienta de cribado correcta: la **anamnesis estructurada**. Presenta el cuestionario **HEMSTOP**, su interpretación y sus límites, como puerta de entrada al manejo del paciente con riesgo hemorrágico (PBM-16 a 18).

Índice

1. Por qué el TP/TTPa de rutina no sirve para cribar
2. El cuestionario HEMSTOP
3. Interpretación y rendimiento
4. A quién estudiar más y cómo actuar
5. Mensaje nuclear y conexiones
6. Verificación bibliográfica
7. Referencias

1. Por qué el TP/TTPa de rutina no sirve para cribar

Las pruebas de coagulación convencionales se diseñaron para **diagnosticar** coagulopatías conocidas, no para **cribar** poblaciones asintomáticas. En el paciente sin historia hemorrágica tienen **bajo valor predictivo**: muchos trastornos relevantes (enfermedad de von Willebrand, disfunción plaquetaria) cursan con TP/TTPa normales, mientras que alteraciones análisis sin traducción clínica generan estudios y demoras innecesarias [1]. Por eso las guías recomiendan **no cribar de forma indiscriminada** con coagulación básica.

PUNTOS CLAVE

- El cribado correcto es la **anamnesis estructurada**, no el TP/TTPa de rutina [1].
- HEMSTOP es un cuestionario de **7 ítems** con alta especificidad para detectar a quien precisa estudio [1].
- Un cribado clínico positivo —no un número anómalo aislado— es lo que indica profundizar.

2. El cuestionario HEMSTOP

HEMSTOP es un cuestionario dicotómico de siete preguntas cuyo acrónimo resume los dominios explorados [1]:

DOMINIOS HEMSTOP

- **H**ematoma — hematomas frecuentes/desproporcionados.
- **E**morragia (hemorragia) — sangrado que precisó atención médica.
- **M**enorragia — reglas abundantes (en mujeres).
- **S**urgery (cirugía) — sangrado anormal en cirugías previas.
- **T**ooth (extracción dental) — sangrado prolongado tras extracciones.
- **O**bstetrics (obstetricia) — hemorragia en el parto.
- **P**arents (familiares) — antecedentes familiares de trastorno hemorrágico.

3. Interpretación y rendimiento

En el estudio de validación, una puntuación **≥ 2** identificó a los pacientes que requerían precauciones hemostáticas perioperatorias con una **especificidad del 98,6 %** y una **sensibilidad del 89,5 %**, muy superior al rendimiento de las pruebas de coagulación estándar (sensibilidad ≈ 26 %) [1]. Es decir: el cuestionario discrimina mucho mejor que el TP/TTPa quién tiene un riesgo hemorrágico real.

PERLA

Un HEMSTOP **≥ 2** debe llevar a estudio dirigido de hemostasia antes de cirugía de riesgo; un HEMSTOP de 0 en un paciente sin fármacos antitrombóticos hace muy improbable un trastorno hemorrágico oculto y evita pruebas inútiles [1].

4. A quién estudiar más y cómo actuar

Ante un cribado positivo (o historia clara), conviene **estudio dirigido**: hemograma con plaquetas, coagulación, y según sospecha, estudio de von Willebrand, función plaquetaria o factores específicos, idealmente con apoyo de hematología [1]. También debe revisarse de forma sistemática la **medicación antitrombótica** (antiagregantes y anticoagulantes), cuyo manejo perioperatorio se desarrolla en PBM-16. La guía ESAIC respalda este enfoque escalonado basado en la historia [2].

5. Mensaje nuclear y conexiones

Mensaje nuclear (equilibrado): el cribado del riesgo hemorrágico debe basarse en una **anamnesis estructurada** (p. ej. HEMSTOP), no en el TP/TTPa de rutina, que tiene bajo rendimiento y genera falsos positivos; HEMSTOP ≥ 2 detecta con alta especificidad a quien precisa estudio. La herramienta orienta, y la decisión final integra la historia y la medicación.

Conecta con **PBM-16** (manejo de antitrombóticos), **PBM-17** (coagulopatías) y **PBM-18** (fármacos hemostáticos); es la puerta de entrada del eje de hemostasia. Resumen operativo en **P-QR-05**.

RESUMEN EN UNA FRASE

Criba el riesgo hemorrágico con preguntas (HEMSTOP), no con TP/TTPa de rutina —estudia a fondo solo a quien tiene historia o un score ≥ 2—.

6. Verificación bibliográfica

Documento **REV** anclado en el estudio de validación de HEMSTOP [1] y respaldado por la guía ESAIC [2] y el consenso de Frankfurt [3], verificados contra PubMed (autoría, título, revista, año, DOI/PMID). Las cifras de rendimiento (especificidad 98,6 %, sensibilidad 89,5 % para score ≥ 2; sensibilidad ≈ 26 % de las pruebas estándar) proceden directamente de la fuente [1], que se presenta como herramienta de cribado a validar en más contextos.

7. Referencias

1. Bonhomme F, Boehlen F, Clergue F, de Moerloose P. Preoperative hemostatic assessment: a new and simple bleeding questionnaire (HEMSTOP). *Can J Anaesth* 2016;63(9):1007–1015. doi:10.1007/s12630-016-0688-9 · PMID 27369959.

2. Kietaibl S, Ahmed A, Afshari A, Albaladejo P, Aldecoa C, Barauskas G, et al. Management of severe peri-operative bleeding: Guidelines from the European Society of Anaesthesiology and Intensive Care: Second update 2022. *Eur J Anaesthesiol* 2023;40(4):226–304. doi:10.1097/EJA.0000000000001803 · PMID 36855941.

3. Mueller MM, Van Remoortel H, Meybohm P, Aranko K, Aubron C, Burger R, et al. Patient Blood Management: Recommendations From the 2018 Frankfurt Consensus Conference. *JAMA* 2019;321(10):983–997. doi:10.1001/jama.2019.0554 · PMID 30860564.

Serie Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria (PBM) - Documento PBM-15 - Modulo 5 (eje hemostasia) - ancla REV - 2026. Sintesis docente en espanol para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL). Cifras procedentes de fuentes primarias indexadas verificadas contra PubMed. No sustituye al juicio clinico ni a los protocolos locales vigentes.

Ideacion: *Emilio Garcia Hernandez - Licenciado Especialista en Anestesiologia y Reanimacion - CAUSA - SACYL.*